

MEMORANDUM PRAWNE UD207 — WERSJA 2.0

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Projekt UD207 w wersji 4.0 opublikowanej 13 maja 2026 r. (przyjęty przez Radę Ministrów 12 maja 2026 r.; kontynuacja prac legislacyjnych po konsultacjach publicznych z czerwca 2025 r.)

Warszawa, 16 maja 2026 r.

Adresaci: — Biuro Analiz Sejmowych — Komisja Zdrowia Sejmu RP X kadencji — Komisja Ustawodawcza Sejmu RP — Komisja Zdrowia Senatu RP — Kancelarie prawne, prawnicy konstytucjonaliści, posłowie i senatorowie zainteresowani analizą prawną projektu

Opracowanie: Pakiet obywatelski UD207 — na podstawie analizy prawnej autorstwa M. (po korektach Perplexity v13 + ChatGPT v14 + Perplexity v15). Pełna analiza w wersji szczegółowej dostępna w Załączniku 1 Policy Paper EBM v1.10, Część B.

Charakter: materiał analityczny; nie stanowi opinii prawnej w rozumieniu obrotu profesjonalnego.

TEZA GŁÓWNA

Projekt UD207 dąży do społecznie legitymowanego celu — ochrony pacjentów przed oszustwami zdrowotnymi — jednak realizuje go za pomocą narzędzia nieprecyzyjnego, nadmiernie represyjnego i systemowo niespójnego. W obecnym kształcie tworzy nowy reżim quasi-karny z karami administracyjnymi do 1 000 000 zł, bez zapewnienia gwarancji wymaganych przez Konstytucję RP, prawo Unii Europejskiej i Europejską Konwencję Praw Człowieka. Projekt nie wypełnia żadnej rzeczywistej luki, której nie pokrywają już istniejące przepisy karne i administracyjne — a zarazem stwarza poważne ryzyko dla legalnej działalności medycznej, naukowej, dziennikarskiej i rynkowej, w tym dla legalnych terapii eksperymentalnych prowadzonych w trybach przewidzianych prawem UE.

Niniejsze memorandum przedstawia siedem zarzutów głównych (A), sześć zarzutów pomocniczych (B), dziesięć rekomendowanych poprawek legislacyjnych (C) oraz tabelę synoptyczną (D) — w formacie operacyjnym dla biur analiz, kancelarii i prawników parlamentarnych.

A. ZARZUTY GŁÓWNE

A.1. Nieostrość definicji „praktyki pseudomedycznej” (art. 2 Konstytucji RP — *lex certa*)

Art. 67zj ust. 1 opiera delikt administracyjny na trzech pojęciach blankietowych:

— ****„aktualna wiedza medyczna“*** — pojęcie dynamiczne, zależne od konsensusu naukowego. **Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5.06.2019 r., III KK 212/18** (sprawa z art. 160 § 2 k.k. dotycząca błędu diagnostycznego) wskazał, że ocena zgodności postępowania lekarza z „aktualną wiedzą medyczną” wymaga każdorazowego dowodu z opinii biegłych, a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.). Przeniesienie tego kryterium do deliktu administracyjnego — bez analogicznych gwarancji procesowych i z przerzuceniem ciężaru dowodu — rodzi stan arbitralności trudny do pogodzenia z art. 2 Konstytucji.

— **„świadczanie zdrowotne”** — pojęcie znane ustawie o działalności leczniczej, lecz niewystarczająco precyzyjne w reżimie sankcyjnym: wymaga wyraźnego rozgraniczenia od działań edukacyjnych, profilaktycznych, dobrostanowych, dietetycznych, religijnych, coachingowych i dziennikarskich.

— **„publiczne rozpowszechnianie”** — pojęcie niedookreślone w epoce mediów społecznościowych; niejasny zakres: wpisy w zamkniętych grupach, materiały szkoleniowe, wypowiedzi naukowe.

Linia TK wymaga podwyższonego standardu określoności dla regulacji represyjnych: **K 11/94, P 19/06, P 46/13**. W orzecznictwie sygnalizacyjnym TK (postanowienia serii S) wielokrotnie wskazywano nieostrość pojęć represyjnych jako samodzielną wadę konstytucyjną — por. **P 29/13 (TK, 2014)** dot. naruszenia zasady przyzwoitej legislacji z art. 2 Konstytucji.

A.2. Engel + wyłączenie KPA = postępowanie quasi-karne bez gwarancji (art. 6 EKPC, art. 42 ust. 3 Konstytucji RP)

Postępowanie RPP spełnia **wszystkie trzy kryteria Engela** (Engel v. Holandia, 8.06.1976):

— zakaz o charakterze ogólnym (adresowany do całego rynku zdrowia); — represyjny cel normy (sankcja, nie wyrównanie szkody); — surowość sankcji — do 1 000 000 zł.

Spełnienie kryteriów Engela aktywuje pełen standard art. 6 EKPC. Tymczasem **art. 64a ust. 4** projektu w odniesieniu do **decyzji tymczasowej z ust. 3**:

— wyłącza art. 10 KPA (prawo czynnego udziału strony); — wyłącza art. 81 KPA (prawo wypowiedzenia się co do dowodów); — nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy — bez indywidualnej oceny przesłanek art. 108 KPA (sprzecznosc z K 22/06 TK).

Połączenie tych konstrukcji rodzi **bardzo wysokie ryzyko kwalifikacji postępowania jako sprawy o charakterze quasi-karnym w rozumieniu art. 6 EKPC przy braku pełnych gwarancji proceduralnych właściwych dla takiej kwalifikacji**. Niezależne stanowisko 7 organizacji pracodawców systemu ochrony zdrowia z lipca 2025 r. (Pracodawcy dla Zdrowia, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i in.) określa art. 64a ust. 4 jako „*rażące naruszenie KPA*”.

A.3. Ciężar dowodu (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, art. 6 ust. 2 EKPC, art. 48 KPP UE)

Art. 67zł ust. 4 przenosi na stronę ciężar wykazania okoliczności egzoneracyjnych z ust. 3 (zaprzestanie praktyki, usunięcie skutków). Samo w sobie nie jest to pełne odwrócenie ciężaru dowodu co do wszystkich znamion. Jednak w połączeniu z brakiem obowiązku organu wykazania rzeczywistej szkodliwości praktyki (wystarczy subsumpcja pod definicję art. 67zj), nieostrością tej definicji, rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wyłączeniem art. 10 i 81 KPA w decyzji tymczasowej, konstrukcja ta **rodzi poważne ryzyko nierównowagi proceduralnej na niekorzyść strony**. Stanowisko 7 organizacji pracodawców (lipiec 2025) podnosi to jako odrębny, samodzielny zarzut konstytucyjny.

A.4. Publikacja przed prawomocnością (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, art. 6 ust. 2 EKPC, art. 5 i 35 RODO)

Projekt przewiduje trzy mechanizmy ujawniania informacji o praktykach:

— **art. 64a ust. 1–2**: publiczne ostrzeżenie / podanie informacji do publicznej wiadomości w drodze postanowienia, na które służy skarga do sądu administracyjnego; wydawane przed prawomocnością decyzji co do meritum; — **art. 64a ust. 3 (w zw. z ust. 4)**: decyzja tymczasowa o zaniechaniu zachowań z rygorem natychmiastowej wykonalności; do tej decyzji nie stosuje się art. 10 i 81 KPA; — **art. 47 ust. 1b, art. 64 ust. 4a, art. 67zł ust. 5**: publikacja decyzji w całości lub części, na koszt podmiotu, z oznaczeniem prawomocności. KPRM deklaruje anonimizację danych pacjentów.

Problem konstytucyjny nie polega na publikacji danych osobowych pacjentów (są anonimizowane), lecz na publikacji informacji o praktyce/podmiocie przed zakończeniem kontroli sądowej — z nieodwracalnym skutkiem reputacyjnym. ETPC: *Allenet de Ribemont v. Francja* (10.02.1995), *Khuzhin v. Rosja* (23.10.2008). Brak DPIA wymaganej przez art. 35 RODO; brak doprecyzowania retencji, deindeksacji, trybu usunięcia po uchyleniu decyzji.

A.5. Brak luki legislacyjnej — paradoksy farmaceutyczne (art. 31 ust. 3 Konstytucji — proporcjonalność)

Tabela istniejących reżimów represyjnych vs. UD207:

Zachowanie	Istniejący przepis	Sankcja
Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień	art. 58 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty	grzywna; wariant kwalifikowany do 1 roku pozbawienia wolności
Eksperyment medyczny bez wymaganej zgody/zezwoleń	art. 58 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty	do 3 lat pozbawienia wolności
Oszustwo medyczne	art. 286 k.k.	do 8 lat pozbawienia wolności
Nieuczciwa praktyka rynkowa	UOKiK / ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom	do 10% obrotu

	rynkowym	
Naruszenie standardów zawodowych	samorząd lekarski (NIL/NSL)	upomnienie – zakaz wykonywania zawodu
Pseudomedycyna wg UD207	RPP	do 1 mln zł + ok. 170 tys. zł na osobę zarządzającą (art. 69b)

Istniejące instrumenty są dla zachowań ciężkich surowsze (kara pozbawienia wolności) i precyzyjniejsze (znamiona czynu). UD207 dodaje kolejny reżim represyjny dla zachowań już penalizowanych — bez wypełnienia rzeczywistej luki legislacyjnej. Test proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji budzi poważne wątpliwości.

Paradoks pierwszy (Prawo farmaceutyczne — produkty legalnie dopuszczone): producent może legalnie sprzedawać homeopatyczny produkt leczniczy dopuszczony do obrotu przez Prezesa URPL (art. 21 Prawa farmaceutycznego), lecz jego promocja zgodna z funkcją produktu staje się praktyką pseudomedyczną wg art. 67zj. Wewnętrzna sprzeczność legislacyjna niemożliwa do naprawienia bez wycofania projektu lub klauzuli wyłączającej. Analogicznie: suplementy diety (rozporządzenie 1924/2006/WE), wyroby medyczne (rozporządzenie 2017/745), kosmetyki.

Paradoks drugi (compassionate use / named-patient — terapie eksperymentalne legalne w UE): dyrektywa 2001/83/WE art. 5 ust. 1 oraz rozporządzenie 726/2004 art. 83 przewidują indywidualny dostęp pacjenta do substancji bez dopuszczenia rynkowego. W trybie tym w Niemczech udokumentowano kliniczne podanie salinomycyny (Naujokat C., Steinhart R., J Biomed Biotechnol 2012;2012:950658, DOI 10.1155/2012/950658). Polskie prawo: art. 4 ustawy o zawodach lekarza (autonomia terapeutyczna, wyrok SN z 10.02.2010 r.) i art. 37 Prawa farmaceutycznego (off-label). UD207 nie zawiera wyłączenia — publiczna wypowiedź lekarza o takiej terapii (publikacja, konferencja, wyjaśnienie pacjentowi) może zostać zakwalifikowana jako pseudomedycyna z sankcją 1 mln zł. Tworzy to **arbitralność geograficzną** w obrębie UE i ryzyko kolizji z art. 56 TFUE oraz art. 4 ust. 3 TUE (zasada lojalnej współpracy).

A.6. Dwuinstancyjność i prawo do sądu (art. 78, 45, 176 Konstytucji RP)

Projekt nie zapewnia ścieżki sądowej z merytoryczną kontrolą decyzji — model SOKiK wymagany przez TK SK 27/03 dla decyzji o charakterze represyjnym. Schemat administracyjnoprawny uznany przez TK za niewystarczający. Rygor natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy bez indywidualnej oceny przesłanek narusza linię TK K 22/06.

A.7. Odpowiedzialność osób zarządzających (art. 69b)

Projekt zawiera ogólne dyrektywy wymiaru kary (art. 70), ale nie zapewnia gwarancji właściwych dla odpowiedzialności osobistej:

— brak obrony należytej staranności (due diligence defence); — brak precyzyjnego rozróżnienia zakresu faktycznego wpływu osoby zarządzającej; — brak jednoznacznego

standardu winy; — brak mechanizmu zapobiegającego automatycznemu karaniu zarządu za sporne rozstrzygnięcie medyczno-naukowe.

Kara do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia (~ 170 000 zł) kwalifikowana jako „criminal” w rozumieniu Engela aktywuje pełen standard art. 6 EKPC. Sprzeczne z linią TK K 1/14, P 124/15.

B. ZARZUTY POMOCNICZE

B.1. RODO (rozporządzenie 2016/679)

Brak DPIA (art. 35 — ocena skutków dla ochrony danych), brak ograniczenia retencji publikacji, brak mechanizmu prawa do bycia zapomnianym (art. 17), brak pełnej minimalizacji danych (art. 5). Strona internetowa RPP dostępna globalnie — transgraniczne przetwarzanie danych w rozumieniu RODO bez koordynacji z UODO.

B.2. DSA i EMFA (koordynacja, nie automatyczna kolizja)

W zakresie egzekwowania zakazów wobec treści internetowych projekt powinien zostać skoordynowany z DSA (rozp. 2022/2065, art. 16–22 — procedura notice-and-action), zwłaszcza gdy decyzje RPP miałyby prowadzić do usuwania treści z platform hostingowych. W zakresie profesjonalnych publikacji medialnych — wyraźne wyłączenie dla działalności dziennikarskiej zgodnie z Prawem prasowym i standardami EMFA (rozp. 2024/1083).

B.3. Dyrektywa 2005/29/WE (ryzyko kolizji kompetencyjnej)

Projekt powiela zakazy praktyk wprowadzających w błąd, przenosząc je do surowszego reżimu RPP — ryzyko kolizji z zasadą pełnej harmonizacji (VTB-VAB C-261/07, Plus Warenhandelsgesellschaft C-304/08). Wyjątek sektorowy z motywu 9 i art. 3 ust. 3 dyrektywy dotyczy przepisów krajowych o zdrowiu i bezpieczeństwie produktów; rdzeń UD207 to penalizacja komunikatu rynkowego o metodach. Argument formułować jako ryzyko kolizji kompetencyjnej wymagającej harmonizacji, nie jako oczywiste naruszenie.

B.4. Ochrona sygnalistów (dyrektywa 2019/1937, ustawa z 14.06.2024 r.)

Znamiona art. 67zj mogą obejmować osoby ujawniające nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia (lekarz, naukowiec, dziennikarz). Konstrukcja „korzyść majątkowa lub osobista” jest pozornym filtrem — sygnalista, naukowiec budujący dorobek, dziennikarz zarabiający honorarium technicznie spełniają to znamię. Projekt nie zawiera klauzuli wyłączającej dla sygnalistów.

B.5. Art. 17 Konstytucji RP — relacja z samorządami zawodowymi

Projekt tworzy równoległy reżim odpowiedzialności wobec materii pokrywającej się z odpowiedzialnością zawodową lekarzy i innych zawodów medycznych. Problemem nie jest sama kompetencja RPP, lecz brak mechanizmu koordynacji, ryzyko podwójnej

odpowiedzialności (ne bis in idem) oraz brak jasnego rozgraniczenia między deliktem administracyjnym a przewinieniem zawodowym.

B.6. Konwencja z Oviedo (argument interpretacyjny)

Polska podpisała w 1999 r., ale nie ratyfikowała Konwencji z Oviedo. Konwencja stanowi europejski standard bioetyczny i argument interpretacyjny dotyczący świadomej zgody oraz autonomii pacjenta. Polska znajduje się w grupie 8 dużych państw nieratyfikujących (obok m.in. Niemiec). Na tle wybranych systemów europejskich, zwłaszcza niemieckiego Heilpraktiker (od 17.02.1939 r., ok. 50 tys. specjalistów), UD207 wybiera model wyraźnie bardziej represyjny niż regulacyjny. ETPC: **Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia** (302/02, 10.06.2010) — „*The right to make one's own medical choices — including the refusal of particular forms of treatment — falls within the sphere of personal autonomy*” (art. 8 EKPC, art. 9 EKPC).

C. REKOMENDOWANE POPRAWKI LEGISLACYJNE

1. **Fundamentalne przerebadanie definicji praktyki pseudomedycznej (art. 67zj)** — zastąpienie pojęć blankietowych weryfikowalnymi znamionami zachowań; klauzule wyłączające dla nauki, dziennikarstwa, sygnalistów, świadomych wyborów pacjenta, legalnie dopuszczonych produktów leczniczych, terapii w trybie compassionate use / named-patient / off-label.
2. **Przywrócenie art. 10 i 81 KPA** w decyzji tymczasowej z art. 64a ust. 3 — lub ograniczenie wyłączenia do sytuacji nadzwyczajnych z przesłanek art. 10 § 2 KPA.
3. **Usunięcie konstrukcji rodzącej ryzyko nierównowagi proceduralnej** w art. 67zl ust. 4 — przywrócenie pełnej zasady domniemania niewinności.
4. **Uzależnienie publikacji decyzji** od prawomocności (lub ściśle oznaczenie tymczasowości + tryb usunięcia po uchyleniu) oraz pełna regulacja zgodności z RODO: retencja, anonimizacja, deindeksacja, DPIA, prawo do bycia zapomnianym.
5. **Wprowadzenie modelu progresywnego sankcji:** ostrzeżenie → upomnienie → kara łagodniejsza → kara surowa; miarkowanie według skali działalności.
6. **Mechanizm koordynacji** z UOKiK, samorządami zawodowymi, Prawem farmaceutycznym, RODO, DSA i EMFA (test ścisłej konieczności kumulacji wg TSUE Menci, Garlsson).
7. **Standard winy i obrona należytej staranności** dla osób zarządzających (art. 69b); zakaz automatyzmu w karaniu zarządu za sporne rozstrzygnięcia medyczno-naukowe.
8. **Ścieżka sądowej kontroli merytorycznej** decyzji RPP (model SOKiK, zgodnie z TK SK 27/03); rezygnacja z rygору natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy.
9. **Wydłużenie vacatio legis** do co najmniej 6 miesięcy zgodnie z linią TK (K 47/14, 14.10.2015) + pełne przepisy intertemporalne.

10. **Uzupełnienie OSR** projektu o dane ilościowe skali zjawiska (liczba pseudomedyków, skala finansowa, liczba poszkodowanych pacjentów, ocena skuteczności istniejących instrumentów) — zgodnie z art. 50 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów.
11. **Ustawowy obowiązek RPP zapewnienia ciągłości opieki** dotkniętym pacjentom — w sytuacjach, w których decyzja RPP (zwłaszcza tymczasowa z art. 64a) skutkuje przerwaniem leczenia. Przed wykonaniem decyzji RPP wskazuje konkretny podmiot leczniczy NFZ przejmujący opiekę nad pacjentami wykluczonego podmiotu, z zachowaniem harmonogramu leczenia onkologicznego, neurologicznego i innych ścieżek wymagających kontynuacji. Casus z 2025 r. — w którym ok. 11 miesięcy zawieszenia lekarza onkologa przez Naczelny Sąd Lekarski (orzeczenie z 9.01.2025; uchylone przez SN w XII 2025 r. jako wadliwe proceduralnie) pozostawiło kilkudziesięciu pacjentów onkologicznych bez opieki, mimo udokumentowanych apeli do RPP i innych urzędów — stanowi empiryczny dowód strukturalnej luki regulacyjnej.
12. **Klauzula świadomej zgody pacjenta jako ustawowe wyłączenie spod sankcji** — propozycja pozytywna pakietu obywatelskiego.

Brzmienie proponowane do art. 67zj UD207 (nowy ust. 3):

„Świadczenie zdrowotne nie stanowi praktyki, o której mowa w ust. 1, jeżeli zostało wykonane wobec pacjenta, który łącznie:

- 1) otrzymał pisemną informację o stanie wiedzy medycznej dotyczącej proponowanej metody, obejmującą: poziom dowodów naukowych zgodnie z systemem OCEBM lub GRADE; alternatywne metody leczenia zgodne z aktualną wiedzą medyczną; ryzyko, działania niepożądane i brak gwarancji skuteczności; status rejestracyjny substancji lub wyrobu medycznego;
- 2) potwierdził pisemnie świadomą zgodę zgodnie z art. 16 i 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 5 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie;
- 3) nie był odwodzony od leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną ani nie obiecywano mu wyleczenia;
- 4) świadczenie zostało wykonane przez podmiot leczniczy wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z prowadzeniem dokumentacji medycznej zgodnie z rozdziałem 7 ustawy o prawach pacjenta.”

Podstawy konstytucyjno-prawne klauzuli:

- **art. 47 Konstytucji RP** — prawo do prywatności obejmuje decyzje o własnym ciele (TK U 10/92, SK 14/13);
- **art. 41 ust. 1 Konstytucji RP** — wolność osobista jako autonomia decyzji medycznych;
- **art. 31 ust. 3 Konstytucji RP** — test proporcjonalności wymaga środka najmniej dolegliwego osiągnącego cel; klauzula chroni pacjenta nieświadomego/oszukanego (warunki 1–4 muszą być spełnione łącznie), pozostawiając autonomię pacjentowi świadomemu;

- **art. 16–17 u.p.p.** — informed consent fundamentem polskiego prawa pacjenta;
- **art. 8 EKPC** — *Pretty v. UK* (2346/02, 29.04.2002); *Vavříčka v. Czechy* (8.04.2021); *Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia* (302/02, 10.06.2010 — „The right to make one's own medical choices...”);
- **art. 5 Konwencji z Oviedo** — „An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it”;
- **art. 3 Karty Praw Podstawowych UE** — prawo do integralności osoby z explicitynym wymogiem świadomej zgody;
- **modele zagraniczne:** Heilpraktikergesetz (DE, 17.02.1939, ok. 50 tys. specjalistów) — model wyboru pacjenta po informacji; art. 118a Konstytucji CH (5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia od 2017 r.).

Mechanizm i skutki proponowanego rozwiązania:

- Pacjent **świadomy** (otrzymał pisemną informację o poziomie dowodów wg OCEBM/GRADE, alternatywach, ryzyku, statusie substancji) i **wyraził pisemną zgodę** — zachowuje autonomię wyboru terapii komplementarnej, eksperymentalnej (compassionate use, named-patient), off-label, integracyjnej — bez narażania lekarza/podmiotu na sankcję administracyjną.
- Pacjent **nieświadomy lub oszukany** pozostaje chroniony przez istniejące reżimy: **art. 286 k.k.** (oszustwo, do 8 lat pozbawienia wolności); **art. 58 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty** (świadczenia bez uprawnień — grzywna lub do 1 roku); **odpowiedzialność zawodowa** lekarzy/pielęgniarek/fizjoterapeutów (art. 17 Konstytucji RP); **UOKiK** (ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych z 23.08.2007 r. — interes konsumenta); **Prawo prasowe i Prawo farmaceutyczne** (reklama, oświadczenia zdrowotne).
- UD207 nadal obejmuje sytuacje **rzeczywistej pseudomedycyny** — wprowadzenia w błąd, fałszywej obietnicy wyleczenia, odwodzenia od leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
- Klauzula realizuje **fundament etyki medycznej** — informed consent — i jest zgodna z międzynarodowym standardem (Oviedo, EKPC, KPP UE).

Spójność systemowa. Bez tej klauzuli UD207 funkcjonuje jako **paternalistyczna eliminacja wyboru** — chroni pacjenta przed wyborami, których pacjent chce dokonać po pełnej informacji. To stanowi **wewnętrzna sprzeczność systemową** z ustawą o prawach pacjenta z 2008 r., której art. 16–17 statuują świadomą zgodę jako prawo nadrzędne. Klauzula tę sprzeczność usuwa.

D. TABELA SYNOPTYCZNA: PRZEPIS → PROBLEM → PROPOZYCJA

Przepis projektu	Problem konstytucyjny / prawny	Proponowana zmiana
Art. 67zj ust. 1	Trzy pojęcia blankietowe; naruszenie lex certa (art. 2 Konstytucji); SN III KK	Konkretne, weryfikowalne znamiona + klauzule wyłączające (nauka,

	212/18 wskazuje kontekstualny charakter pojęcia	dziennikarstwo, sygnaliści, legalne produkty, compassionate use, świadomy wybór pacjenta)
Art. 67zj ust. 1 (paradoks 1)	Penalizacja promocji legalnie dopuszczonych produktów leczniczych (homeopatia, suplementy, wyroby med.)	Wyraźna klauzula rozgraniczająca z Prawem farmaceutycznym i prawem UE
Art. 67zj ust. 1 (paradoks 2)	Penalizacja wypowiedzi o legalnych w UE terapiach w trybie compassionate use / named-patient	Wyłączenie dla legalnego stosowania substancji w trybach przewidzianych prawem UE (art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE)
Art. 64a ust. 1–2	Publiczne ostrzeżenie przed prawomocnością; ryzyko stygmatyzacji	Warunek prawomocności lub ścisłe ograniczenie tymczasowe + tryb usunięcia
Art. 64a ust. 3 (z ust. 4)	Decyzja tymczasowa z rygorem natychmiastowej wykonalności + wyłączenie art. 10 i 81 KPA; kryteria Engela	Usunąć wyłączenie KPA lub ograniczyć do przesłanek art. 10 § 2 KPA + ścieżka SOKiK
Art. 47 ust. 1b / 64 ust. 4a / 67zl ust. 5	Publikacja decyzji bez pełnej regulacji RODO (retencja, deindeksacja, DPIA)	Pełna regulacja zgodna z RODO + warunek prawomocności
Art. 67zl ust. 4	Ciężar dowodu okoliczności egzoneracyjnych + funkcjonalna nierównowaga proceduralna	Przywrócenie pełnej zasady domniemania niewinności
Art. 69b	Odpowiedzialność osobista bez gwarancji karnoprawnych	Standard winy, obrona należytej staranności, zakaz automatyzmu
Art. 70	Ogólne dyrektywy wymiaru kary bez progresji	Model progresywny: ostrzeżenie → upomnienie → kara łagodna → maksymalna
Vacatio legis (3 miesiące)	50% standardu TK z K 47/14	